

• 药物与临床 •

维生素 E 的药物相互作用

裴 的 善

311719 浙江省淳安县第二人民医院

维生素 E 又称生育酚,是一种脂溶性维生素。早年人们仅了解维生素 E 能调节和妊娠关系密切的内分泌、自主神经系统的功能,因此,临床上常用维生素 E 治疗不孕、习惯性或先兆流产^[1]。随着对维生素 E 的药理作用研究的深入,临床应用与日俱增,维生素 E 与其他药物间的相互作用也日趋复杂。有利的相互作用广为人知,而不利的药物相互作用和(或)有争议的相互作用常被临床医生忽视。鉴于此,结合文献将其不利的药物相互作用与尚有争议的相互作用概述如下,以供借鉴。

1 维生素 E 与其他药物不利的相互作用

1.1 与液状石蜡、新霉素 后二药均可影响维生素 E 的吸收,故不宜伍用^[2~4]。

1.2 与口服避孕药 口服避孕药可降低维生素 E 的血清浓度,使其作用减弱,有可能导致维生素 E 缺乏症^[5,6]。

1.3 与洋地黄 维生素 E 能增加洋地黄的毒性作用,两药伍用时,应减少洋地黄的用量^[6]。

1.4 与氢氧化铝、硫糖铝 氢氧化铝、硫糖铝大剂量时可使小肠的胆酸沉淀,降低维生素 E 的吸收^[4]。

1.5 与维生素 K 有人认为维生素 E 有拮抗维生素 K 的止血作用,观察到摄入维生素 E 试验期间,发现依赖于维生素 K 凝血因子的浓度有所下降,但停药维生素 E 之后,其值即恢复正常^[7]。

1.6 与降血脂药 降血脂药如考来烯胺、考来替泊。维生素 E 可影响降血脂药的吸收^[4]。

1.7 与降胆固醇脂药 消胆胺、消胆宁、降胆葡胺等离子交换树脂,减少胆道对维生素 E 的吸收。与树脂的吸附作用有关^[2]。

1.8 与抗凝药(华法林、香豆素及其衍生物) 维生素 E 可降低抗凝药的作用。

Corrigan 报道^[8]1 例用华法林的妇女,服用维生素 E 每天 1200 国际单位(IU)达 2 个月以上,开始出血,发现其凝血酶原时间是 36 秒;之后的研究表明,每日 800 国际单位的维生素 E,使凝血因子浓度下降引

起出血。Schroglie 研究观察正常受试者,每天用 42 国际单位维生素 E 达 1 个月,给单剂双香豆素 36 小时反应率下降,由 52%降至 33%。另有报道一 55 岁男性病人,口服华法林、安妥明、地高辛和普鲁卡因酰胺的同时,每日服用 200 毫克以上的维生素 E,引起凝血酶原时间延长和淤斑。其机制尚不很清楚。有人认为维生素 E 在凝血因子的生成中,干扰维生素 K 的活性^[8]。因此,在服用维生素 E 时,应适当减少抗凝剂的用量^[4]。

2 维生素 E 尚有争议的相互作用

维生素 E 的分子结构中苯核上的甲基、羟基和含 16 个碳原子的侧链对生理作用密切关系、若羟基被氧化则无效。因此,服用维生素 E 伍用补血糖浆时,其中所含的甘油磷酸铁、枸橼酸铁铵(三价铁)可与维生素 E 发生氧化还原反应,使其生成对醌式化合物而失效,还应注意少吃或不吃含铁、铜丰富的动物肝脏等^[9]。谢惠民^[10]也认为:在服用维生素 E 期间,应避免食用含无机铁的食物,以免维生素 E 与无机铁结合而失去活性。但是,马沛然等^[11]认为:对中度以上的缺铁性贫血病人,补铁时间长可能引起维生素 E 缺乏,影响贫血的纠正,并将 100 例中等贫血病人随机分为硫酸亚铁加维生素 E 及维生素 C 两组,结果:血红蛋白、红细胞的恢复和网织细胞上升均高于对照组。

综上所述,随着维生素 E 在临床广泛应用,临床医生应加深对维生素 E 不利的药物相互作用的认识,以免影响治疗效果,对目前尚有争议的相互作用,通过药理的研究与临床实践,也可能会进一步达到一致的见解。

3 参考文献

- 1 涂桂生. 维生素 E 的临床应用. 药学通报, 1983, 18 (4): 40
- 2 唐镜波. 药物的相互作用. 郑州: 河南科学技术出版社, 1981. 555~557
- 3 谢惠民. 合理用药. 第 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 1995. 442~443
- 4 中华人民共和国卫生部药典委员会编, 临床用药须知(二

- 部). 北京: 化学工业出版社, 1995. 415~417
- 5 徐叔云. 临床药理学(下册). 合肥: 安徽, 科学技术出版社, 1980, 664~665
- 6 王丕清. 维生素 E 的临床合理应用. 中国乡村医生杂志, 1993, (8): 9~10
- 7 郑自敏. 维生素间的药物相互作用. 中国农村医学, 1995, 23(3): 47
- 8 陈世铭主编. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 北京: 中国科学技术出版社, 1993. 453~454
- 9 黄振东. 应注意口服维生素 E. 中国医院药学杂志, 1986, 6(2): 25
- 10 裴的善. 维生素 E 的临床新用途. 中国药学杂志, 1990, 25(12): 745~746
- 11 马沛然, 等. 维生素 E 配合铁剂治疗缺铁性贫血的疗效观察. 实用儿科杂志, 1988, 3(3): 124
- (1996-07-02 收稿 1997-06-20 修回)
- [于小雪 编发]

· 问题解答 ·

中医治疗糖尿病可以不控制饮食吗?

梁 晓 春

100730 北京协和医院

控制饮食是治疗糖尿病最基本的措施。有人认为中医治疗糖尿病不必控制饮食, 其实不然。中医认为糖尿病的发生和饮食因素有着密切的关系, 并且是最早提出饮食治疗的。

糖尿病和饮食的关系, 早在《素问·奇病论》中就有论述: “其人必数食甘美而多肥也, 肥者令人内热, 甘者令人中满, 故其气上溢转为消渴。”明代《景岳全书》记载: “消渴病, 其为病之肇端, 皆膏粱肥甘之变……皆富贵人病之而贫贱者少有也。”这些精辟的论点足以说明古人早已认识到饮食的偏嗜和不当是导致糖尿病发生的重要因素。因此饮食结构的合理可预防糖尿病的发生, 且饮食控制的好坏直接影响着治疗的效果。

孙思邈是最早提出饮食治疗的先驱, 他在总结古人的经验后提出: “治之愈否, 属在病者, 若能如方节慎, 旬月而瘳, 不自爱惜, 死不旋踵……其所慎者有三: 一饮酒, 二房室, 三咸食及面。”说明中医早已把饮食治疗置于相对首要地位。《儒门事亲》告诫人们, 要减滋味, 戒嗜欲, 节喜怒。并认为: “能从此三者, 消渴亦不足为忧。”除了限制面食以外, 还提出了限制米食、肉食及水果等, 如唐代王焘《外台秘要》记载: “此病特忌房室、热面并干脯一切热肉、粳米饭、李子等。”还告诫患者不可过饱, 以清淡为宜, 禁食辛辣刺激及煎炸之品。孙思邈和王焘均强调, 不节饮食, “纵有金丹亦不可救!” 足可见古代医家对饮食治疗的重视程度。

另外历代医家在长期的医疗实践中总结了不少药膳验方, 值得后人整理提高。如猪胰子 1 只, 低温干燥, 研成粉状, 每服 9 克, 每日 2 次; 三豆饮(绿豆 100 克, 黑豆 50 克, 赤小豆 50 克), 煎汤服用; 苦瓜炒肉(鲜苦瓜 100 克, 瘦猪肉 50 克), 武火炒后食用等等。但服用这些验方时也应将其计算在每天摄入的热量之中。

古代中医提出了糖尿病应限制面食、米食、肉食及水果等重要的论点, 但由于历史条件所限, 未能自成体系。临床不可生搬硬套, 既不能不控制饮食, 又要走出饮食控制的误区, 如不吃粮食, 只吃副食等。要在临床医生指导下, 做到合理调配饮食, 保证人体需要的七类营养素(蛋白质、脂类、碳水化合物、维生素、无机盐及微量元素、膳食纤维、水)的摄入及比例。应以高碳水化合物、低脂、适量的蛋白质为宜, 三者分别占总热量的 60%~70%; 20%~25%; 12%~20%。适当增加食物纤维的摄入, 每天 30~40 克为宜。还应限制钠盐的摄入, 每天应低于 6 克。

另外, 糖尿病人控制饮食后出现饥饿, 可采取以下措施: ①多吃一些低热量、高容积的食品, 如含碳水化合物较低的蔬菜, 如西红柿、黄瓜、大白菜、豆芽等。②多采用粗杂粮代替细粮, 如绿豆粥、莜麦面、豆面、玉米面等。③进餐时先吃副食, 后吃主食, 以减轻饥饿感。

(1998-02-16 收稿 1998-04-10 修回)

[马莉萍 编发]